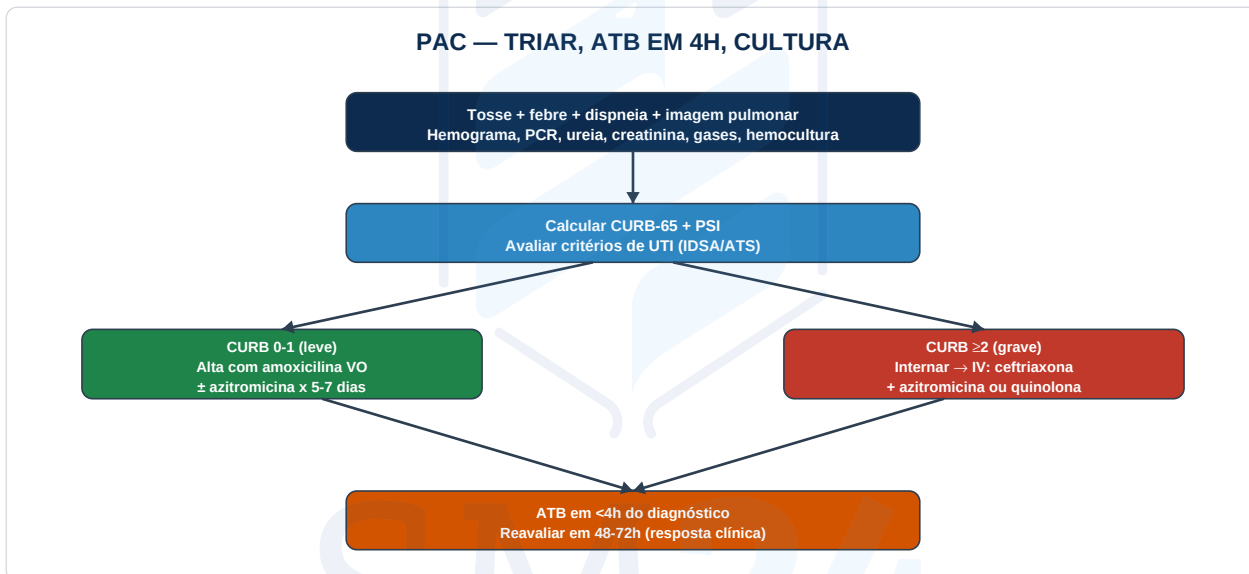


PAC — CURB-65 + ATB EM 4 HORAS

CURB-65 — ESCORE DE GRAVIDADE

Critério	Pontuação	Score → Conduta
C — Confusão (nova)	1	0-1 pontos: baixo risco → alta com ATB oral
U — Ureia >45 mg/dL (>7 mmol/L)	1	2 pontos: risco intermediário → internar
R — Respiração ≥30 ipm	1	3-5 pontos: alto risco → UTI se ≥3
B — PA sistólica <90 ou diastólica ≤60	1	PSI/PORT: alternativa mais sensível
65 — Idade ≥65 anos	1	Critérios IDSA/ATS: UTI se ≥1 maior ou ≥3 menores

ABORDAGEM INICIAL — PAC



ANTIBIOTICOTERAPIA EMPÍRICA — PAC

Cenário	ATB de escolha	Duração
Ambulatorial, sem comorbidade	Amoxicilina 1g VO 8/8h	5 dias
Ambulatorial, comorbidade (DM, DRC, DPOC, imunossupressão)	Amoxicilina-clavulanato OU quinolona respiratória (levofloxacino 750mg/dia)	5-7 dias
Internação (CURB ≥2, sem UTI)	Ceftriaxona 2g IV + azitromicina 500mg IV/VO	7 dias
UTI, sem risco de Pseudomonas	Ceftriaxona + azitromicina OU ceftriaxona + levofloxacino IV	7-10 dias
UTI, risco de Pseudomonas*	Piperacilina-tazobactam + levofloxacino OU cefepima + azitromicina	7-10 dias
Influenza + pneumonia bacteriana	ATB + oseltamivir 75mg 12/12h x 5 dias	7 dias

CRITÉRIOS DE UTI — IDSA/ATS

ADMITIR NA UTI SE...

- 1 critério MAIOR: choque séptico (vasopressor) OU ventilação mecânica invasiva
- ≥3 critérios MENORES: FR ≥30, PaO₂/FiO₂ <250, multilobar, confusão, ureia >45, leucopenia <4.000, trombocitopenia <100k, hipotermia, hipotensão necessitando fluido
- Lactato ≥4 mmol/L ou hipotensão refratária = UTI obrigatória
- Monitorar bacteriemia: hemoculturas ANTES do ATB (2 pares)
- Antígeno urinário Pneumococo + Legionella: em todos os casos graves

AGENTES ESPECIAIS — SUSPEITAR E TRATAR

Legionella pneumophila

- Epidemia hídrica (torres de resfriamento, ar condicionado)
- Clínica extra-pulmonar: diarreia, confusão, hiponatremia
- Raio-X: infiltrado lobar ou multilobar
- Diagnóstico: antígeno urinário (sorotipo 1)
- Tratamento: quinolona (levofloxacino) ou azitromicina
- Notificação compulsória se surto

Pneumocistose (CD4 <200)

- Início insidioso, tosse seca, LDH elevado
- Raio-X: vidro fosco bilateral
- PCR ou imunofluorescência no LBA
- Tratamento: SMX-TMP 15-20 mg/kg/d IV x 21d
- Prednisona se PO₂ <70 mmHg
- Profilaxia: SMX-TMP se CD4 <200

MONITORIZAÇÃO E CRITÉRIOS DE ALTA

RESPOSTA E DESESCALONAMENTO

- ☐ Reavaliação 48-72h: melhora de febre, FR, leucocitose — 'janela de avaliação'
- ☐ Persistência de febre após 72h: resistência, superinfecção, derrame, abscesso, TBC
- ☐ Escalonamento VO: estável, tolerando VO, FR <24, T <38, sem confusão — bioequivalente
- ☐ Alta segura: afebril >24h, FC <100, PA estável, FR <24, SpO₂ >90%, tolerando VO
- ☐ Duração ATB: 5 dias se boa resposta (não fixar em 7-10 dias)
- ☐ Profilaxia influenza anual e vacina pneumocócica em >65 anos, DM, imunossuprimido

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Homem de 72 anos com pneumonia, confusão mental aguda, FR 32 ipm, ureia 60 mg/dL e PA 95/60 mmHg. Qual é o escore CURB-65 e a conduta?

- A) CURB-65 = 2 — alta com ATB oral
- B) CURB-65 = 4 — internação e considerar UTI
- C) CURB-65 = 3 — internação em enfermaria comum
- D) CURB-65 = 1 — alta com azitromicina
- E) CURB-65 = 5 — internação em UTI obrigatória

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é o antibiótico de PRIMEIRA LINHA para PAC leve em paciente sem comorbidades?

- A) Ceftriaxona 1g IV
- B) Levofloxacino 750 mg VO
- C) Amoxicilina 1g VO de 8/8h por 5 dias
- D) Azitromicina 500 mg VO isolada
- E) Piperacilina-tazobactam IV

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Paciente internado com PAC grave (CURB-65 = 3), sem risco de Pseudomonas. Qual esquema antibiótico é recomendado?

- A) Amoxicilina oral isolada
- B) Ceftriaxona 2g IV + azitromicina 500 mg IV/VO
- C) Meropeném + vancomicina
- D) Cotrimoxazol IV
- E) Doxiciclina VO isolada

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Paciente com PAC grave e exame urinário positivo para antígeno de Legionella. Qual antibiótico deve ser adicionado?

- A) Vancomicina IV
- B) Metronidazol IV
- C) Levofloxacino 750 mg IV (ou azitromicina)
- D) Ceftriaxona isolada é suficiente
- E) Ampicilina IV

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Paciente com PAC internado por 48h, afebril, FR 18 ipm, FC 88, PA estável, tolerando dieta oral. Qual conduta é adequada?

- A) Manter antibiótico IV por 7 dias completos
- B) Passar para antibiótico oral equivalente (switch therapy) e considerar alta
- C) Solicitar nova tomografia de controle antes de qualquer mudança
- D) Manter internado por mais 5 dias para observação
- E) Aumentar o espectro do antibiótico por segurança

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Confusão (1) + Ureia >45 (1) + FR ≥30 (1) + PA baixa (1) = CURB-65 = 4. Alto risco → internação + avaliar UTI. Se ≥3 critérios menores IDSA/ATS ou 1 maior (VM, vasopressor) = UTI.

QUESTÃO 2 → Resposta: C

PAC leve, sem comorbidades: amoxicilina 1g VO 8/8h por 5 dias é o padrão (cobre *S. pneumoniae* — mais prevalente). Adicionar azitromicina ou trocar por quinolona se suspeita de atípico ou comorbidade.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

PAC grave hospitalar sem risco de *Pseudomonas*: ceftriaxona 2g IV (cobre pneumococo, *H. influenzae*) + azitromicina (cobre atípicos: *Mycoplasma*, *Legionella*, *Chlamydia*) — padrão das diretrizes IDSA/ATS.

QUESTÃO 4 → Resposta: C

Legionella: quinolona respiratória (levofloxacino 750mg) ou azitromicina são os antibióticos de escolha. Ceftriaxona isolada NÃO cobre *Legionella* (intracelular). Notificar se surto, investigar fonte hídrica.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Switch therapy (escalonamento oral): quando afebril por >24h, FC <100, FR <24, PA estável, SpO2 >90% e tolerando VO. Equivalência amoxicilina IV/VO. Reduz custos e riscos do acesso venoso, sem piora de desfechos.

SM24
Suporte ao Plantão Médico